thể không phân biệt được với một nhiễm trùng đường hô hấp trên ở giai đoạn sớm. Thường không có triệu chứng sốt.

Test chẩn đoán

- Chẩn đoán được dựa trên lâm sàng. Mẫu nuôi cấy đờm không được khuyến khích.
- Ở những bệnh nhân có sốt, bệnh hệ thống, hoặc lớn tuổi, viêm phổi nên được loại trừ dựa trên lâm sàng hoặc X-quang và xét nghiệm chẩn đoán cúm nên được thực hiện tùy thuộc vào mùa và xu hướng bệnh tại địa phương.
- Ho kéo dài >2 tuần ở người lớn nên được xem xét với bệnh ho gà bằng một miếng gạc lấy ở mũi họng để nuôi cấy và PCR.

ĐIỀU TRỊ

- Điều trị triệu chứng và cần được hướng vào việc kiểm soát ho (dextromethorphan 15 mg uống mỗi 6 giờ).
- Sử dụng kháng sinh thường xuyên không được khuyến nghị trừ khi đã được chẩn đoán bệnh ho gà (*Ann Intern Med 2001;134:521*).
- Điều trị bệnh **ho gà** bao gồm clarithromycin 500 mg uống 2 lần/ngày trong vòng 14 ngày hoặc azithromycin 500 mg uống một liều duy nhất tiếp theo sau đó là 250 mg uống hằng ngày trong vòng 4 ngày tiếp theo.
- Trường hợp bệnh ho gà nên được báo cáo cho cơ quan y tế địa phương để tìm kiếm các hỗ trợ và được quản lý điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với azithromycin khi có chỉ định.

Viêm phổi nhiễm phải từ cộng đồng

ĐẠI CƯƠNG

Căn nguyên chủ yếu là *S. pneumoniae* trong đó kháng đa thuốc đang gia tăng nhanh chóng. Viêm phổi được gây ra bởi các tác nhân không điển hình, chẳng hạn như *Legionella pneumophila, C. pneumoniae, M. pneumoniae* hoặc không thể xác định được một cách chính xác về mặt lâm sàng. Cúm và virus hô hấp khác cũng có thể gây bệnh viêm phổi ở người lớn. MRSA là một nguyên nhân quan trọng của bệnh viêm phổi nặng, hoại tử.

CHẨN ĐOÁN

Biểu hiện lâm sàng

Sốt và các triệu chứng hô hấp, bao gồm ho khạc đàm, khó thở và đau ngực kiểu

màng phổi, là các dấu hiệu phổ biến ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Dấu hiệu bao gồm thở nhanh, tiếng ran, hoặc nghe phổi có hội chứng đông đặc.

Test chẩn đoán

- Tất cả các bệnh nhân nội trú cần được đánh giá bệnh phẩm đờm nhuộm Gram hoặc nuôi cấy và cấy máu trước khi điều trị bằng kháng sinh.
- Nếu một tác nhân không điển hình bị nghi ngờ thì cần tìm kháng nguyên Legionella trong nước tiểu. Bệnh phẩm hô hấp có thể được gửi đi xét nghiệm miễn dịch enzyme (enzyme immunoassay–EIA), miễn dịch huỳnh quang, hoặc PCR để phát hiện mầm bệnh không điển hình hoặc do virus khác (bao gồm cả cúm). Xét nghiệm huyết thanh giai đoạn cấp tính và hồi phục có thể hồi cứu để xác định tác nhân vi khuẩn không điển hình bao gồm *C. pneumoniae, C. burnetii* (sốt Q), và *Hantavirus.*
- Chụp X-quang ngực nên được thực hiện và có thể cho thấy sự xơ cứng của thùy phổi, thâm nhiễm kẽ hoặc tổn thương khoang, nhằm xác định chẩn đoán.
- Soi khí phế quản được sử dụng để phát hiện các sinh vật ít phổ biến, đặc biệt là ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, cũng như để xác định tổn thương giải phẫu có liên quan, thực hiện sinh thiết mô bệnh học và có mẫu nuôi cấy chất lượng.

ĐIỀU TRỊ

- Hầu hết các bệnh nhân có thể được điều trị ngoại trú, mặc dù tất cả phải được đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh, bệnh lý kèm theo và nồng độ oxy máu. Hướng dẫn cho phác đồ điều trị theo kinh nghiệm chi tiết đã được công bố, với trọng tâm nhắm mục tiêu tới các tác nhân gây bệnh có khả năng nhất trong các nhóm nguy cơ cụ thể (*Clin Infect Dis 2007;44:S27*). Điều trị kháng sinh cần được thu hẹp một khi đã được xác định được nguyên nhân vi sinh cụ thể.
- **Bệnh nhân ngoại trú** gần đây không có tiếp xúc với kháng sinh và không có bệnh đi kèm nên sử dụng macrolide như azithromycin 500 mg uống một liều duy nhất theo sau đó là 250 mg uống hàng ngày trong vòng 4 ngày tiếp theo, hoặc doxycycline 100 mg uống trong vòng ít nhất 5 ngày.
- **Bệnh nhân ngoại trú có phơi nhiễm kháng sinh** hoặc có các bệnh đi kèm khác nên được điều trị bằng nhóm fluoroquinolone hô hấp (v.d., moxifloxacin) đơn trị liệu hoặc macrolide (azithromycin hoặc clarithromycin) với hoặc không với amoxicillin liều cao 1 g uống 3 lần/ngày trong vòng ít nhất 5 ngày.
- **Các bệnh nhân nhập viện** nên được điều trị bằng ceftriaxone 1 g IV hàng ngày hoặc cefotaxime 1 g IV 8 giờ/lần cộng với một macrolide (azithromycin hoặc clarithromycin), hoặc trị liệu đơn bằng nhóm fluoroquinolone hô hấp. Thời gian tối thiểu của việc điều trị nên là 5 ngày, nhưng thường là dài hơn, các bệnh nhân phải hết sốt trong vòng 48 đến 72 giờ có dấu hiệu cải thiện lâm sàng điều trị trước khi ngưng thuốc.

- **Ở những bệnh nhân bị bệnh nặng**, việc bổ sung các azithromycin hoặc nhóm fluoroquinolone hô hấp kết hợp với β-lactam (ceftriaxone, cefotaxime, ampicillin-sulbactam) là cần thiết để cung cấp điều trị chống lại *L. pneumophila*. Điều trị MRSA với vancomycin hoặc linezolid cũng nên được cân nhắc. Penicillin G IV mà đạt nồng độ cao trong mô phổi, vẫn còn là một điều trị hiệu quả cho trường hợp nhạy cảm với *S. pneumoniae* được phân lập (*Clin Infect Dis 2003; 37: 230*). Để chống lại *Pseudomonas aeruginosa*, thì sử dụng β-lactam kháng pseudomonas (cefepime, piperacillin-tazobactam, meropenem, imipenem) kết hợp với một nhóm fluoroquinolone kháng pseudomonas (ciprofloxacin, levofloxacin) được khuyến nghị sử dụng.
- **Chọc dịch màng phổi** phải được thực hiện, cùng với sự phân tích pH, số lượng tế bào, nhuộm Gram và nuôi cấy vi khuẩn, protein và lactate dehydrogenase (xem Chương 10, Bệnh lý phổi). Viêm mủ màng phổi cần được dẫn lưu.

Áp-xe phổi

ĐẠI CƯƠNG

Áp-xe phổi thường kết quả từ việc hít vào hệ vi sinh vật đường uống. Nhiễm đa khuẩn rất phổ biến và có thể liên quan đến vi khuẩn kỵ khí đường miệng (*Prevotella* spp., *Fusobacterium nucleatum*, *Actinomyces* spp., và vi khuẩn kỵ khí, cầu trực khuẩn vi hiếu khí), trực khuẩn ruột gram âm (*K. pneumoniae*), và *S. aureus*. Các yếu tố nguy cơ bao gồm bệnh răng miệng và điều kiện mà khiến bệnh nhân hít vào các chất dịch ở hầu họng.

CHẨN ĐOÁN

Biểu hiện lâm sàng

Bệnh âm ỉ và có thể tương tự lao phổi, với khó thở, sốt, rét run, vã mồ hôi đêm, sụt cân và ho đờm hoặc máu trong vài tuần.

Test chẩn đoán

Chụp X-quang ngực là nhạy và thường cho thấy thâm nhiễm với tổn thương dạng hang và mức nước-hơi trong nhu mô phổi như các thùy dưới hoặc các phân đoạn sau của thùy trên. Chụp CT có thể rõ hơn về các tổn thương.

ĐIỀU TRỊ

- Điều trị kháng sinh nên bao gồm fluoroquinolone chống phế cầu (moxifloxacin, levofloxacin) kết hợp với clindamycin, hoặc trị liệu đơn bằng β-lactam/chất